

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-03

Toegewezen casussen: **C05** (25-jarige postgraduaatsstudent) en **C06** (32-jarige marketingprofessional)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 40–50 minuten voor beide casussen samen (inclusief leestijd instructies)

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als een geautomatiseerd multi-agentsysteem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)	8
4	Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties	14
6	Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

PHOENIX (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie**: psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **symptomen** (klacht- en toestandsdimensies die beschrijven wat er mis gaat bij de persoon) en **behandelingsopties** (modificeerbare gedragsvariabelen die de symptomen causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

Kerndefinities: symptoom versus behandelingsoptie

Symptoom (S): een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Symptomen zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. intrusieve obsessies, paniekepisoden, prestatieangst). Symptomen zijn geen gedragingen of interventies.

Behandelingsoptie (BO): een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere symptomen en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Behandelingsopties zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. compulsie-uitstel, geplande exposure, post-event verwerking). Een behandelingsoptie is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

- **Symptoom**: intrusieve obsessies, prestatieangst, post-event ruminatie, vermijding van zichtbaarheid.
- **Behandelingsoptie**: compulsie-uitstel (min), geplande exposurestap (ja/nee), post-event verwerkingsoefening (ja/nee), vermijdingslogging (aantal).

Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

EMA is een methode waarbij personen vaak meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel symptomen als behandelingsopties dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar**: via een korte vraag op de smartphone, bijv. (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar**: geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant**: toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid symptoom vs. behandelingsoptie**: klachtdimensies zijn symptomen; modificeerbare gedragingen zijn behandelingsopties.

Het bipartiet netwerk: structuur van het observatiemodel

Na voldoende EMA-monitoring construeert PHOENIX een **bipartiet netwerk**: een graaf met twee kolommensets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Behandelingsopties (BO):** de modificeerbare variabelen.
- **Rechtse kolom – Symptomen (S):** de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten:** de richting loopt van behandelingsoptie naar symptoom (BO → S). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (behandelingsoptie vergroot het symptoom), een *rode* rand op een negatief verband (behandelingsoptie verkleint het symptoom). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de behandelingsopties op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

Overzicht van de vijf taken

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
—	Instructies lezen	Lees de instructiepagina aandachtig door	≈ 5 min
1	Operationalisering	Identificeer 2–6 symptoomlabels (klachtdimensies)	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 behandelingsoptielabels (modificeerbaar, EMA-geschikt)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik alle 5 behandelingsopties van hoog naar laag behandelprioriteit	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 6 EMA-items (2 per behandel doel) uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			40–50 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.
6. **Werk ook bij beperkte informatie.** Klinische teksten bevatten vaak onvoldoende informatie voor definitieve conclusies. Geef *altijd* een antwoord op basis van de beschikbare informatie en uw klinisch oordeel. Laat geen velden blanco zonder reden.

2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**symptomen**) in de klachtttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort symptoomlabel**.

Wat is een symptoom? Een symptoom is een *klacht- of toestandsdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA),
- op DSM-5-TR/ICD-11-niveau: concreet genoeg om afzonderlijk te meten (bijv. “inslaapmoeilijkheden”, niet het brede “slaapstoornis”), maar niet te atomair (niet “wakker om 3u00” als apart symptoom).

Voorbeelden van goede symptoomlabels: intrusieve obsessies, compulsief controlegedrag, prestatieangst, post-event ruminatie, vermijding van zichtbaarheid, anticipatieangst, tijdsbelasting door rituelen.

Let op: gedragingen (bijv. “compulsie-uitstel”), oorzaken (bijv. “perfectionisme”) en behandelstrategieën zijn *geen* symptomen maar behandelingsopties – die horen in Deel 2.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 symptomen**. Laat ongebruikte velden leeg.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie van wat een correct symptoomlabel is.

Hoe formuleert u een correct symptoomlabel?

Klacht (verkorte versie): *“De afgelopen vijf maanden slaap ik slecht: ik lig lang wakker en word vroeg wakker. Overdag ben ik moe en prikkelbaar. Ik beweeg bijna niet meer en zie vrienden nauwelijks nog.”*

Correct ingevulde symptoomlabels (elk één klachtdimensie, expliciet uit de tekst):

- **S-1** Inslaapmoeilijkheden (*“lig lang wakker” → afzonderlijk meetbaar*)
- **S-2** Vroegochtendontwaak (*“word vroeg wakker” → DSM-5-TR: early morning awakening; onderscheidbaar van S-1*)
- **S-3** Vermoeidheid overdag (*“moe overdag” → toestandsdimensie*)
- **S-4** Prikkelbaarheid (*“prikkelbaar” → emotioneel symptoom, los van S-3*)
- **S-5** Sociale terugtrekking (*“zie vrienden nauwelijks” → klachtpatroon*)

Dit zijn GEEN symptoomlabels (horen in Deel 2 als behandelingsoptie):

- *“Weinig bewegen”* → modificeerbaar gedrag, geen klacht; hoort bij Deel 2.
- *“Slaapproblemen”* → te breed: splits naar meetbare dimensies (zie S-1 en S-2).

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent

“De afgelopen anderhalf jaar word ik dagelijks gekweld door opdringerige gedachten over het per ongeluk schaden van anderen – dat ik iemand aangereiden heb, een gasfornuis open heb laten staan, of een deur niet afgesloten heb. Zodra zo’n gedachte opkomt, kan ik niet ophouden met mentaal controleren: ik ga de situatie telkens opnieuw na in mijn hoofd en stel mezelf steeds dezelfde vragen totdat ik tijdelijk gerustgesteld ben. Dit ritueel kost mij dagelijks twee tot vier uur. Inmiddels vermijd ik steeds meer situaties die deze gedachten uitlokken – zoals autorijden of het als laatste verlaten van een ruimte – en vraag ik regelmatig aan anderen of er niets mis is gegaan. Die geruststelling helpt even, maar de gedachten komen sterker terug.”

Uw antwoord

Opdracht: noteer **2–6 symptoomlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels (2–5 woorden); voeg geen beschrijving toe.

Symptoom 1 Label: _____

Symptoom 2 Label: _____

Symptoom 3 Label: _____

Symptoom 4 Label: _____

Symptoom 5 Label: _____

Symptoom 6 Label: _____

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional

“Zo’n twee jaar geleden begon ik toenemende spanning te ervaren in werkgerelateerde situaties waarbij ik zichtbaar ben of beoordeeld word. Voor elke vergadering of presentatie bereid ik mij buitensporig lang voor – soms meerdere uren – uit angst niet competent over te komen. Na afloop piekeren mijn gedachten urenlang over wat ik verkeerd gezegd of gedaan heb. Ik vermijd inmiddels actief kansen waarbij ik mij moet presenteren: ik neem nauwelijks het woord in vergaderingen, wijs leiderschapsrollen af en aarzel bij elke professionele zichtbaarheidsmogelijkheid. Mijn loopbaan lijdt hieronder: ik heb een promotie afgeslagen omdat ik de extra zichtbaarheid niet aankon.”

Uw antwoord

Opdracht: noteer **2–6 symptoomlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels (2–5 woorden); voeg geen beschrijving toe.

Symptoom 1 Label: _____

Symptoom 2 Label: _____

Symptoom 3 Label: _____

Symptoom 4 Label: _____

Symptoom 5 Label: _____

Symptoom 6 Label: _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5** behandelingsoptielabels die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

Wat is een behandelingsoptie in deze context? Een behandelingsoptie is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat de behandelingsoptie de symptomen beïnvloedt.
- **Geen symptoom:** klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* behandelingsopties.

Voorbeelden van goede behandelingsoptielabels: compulsie-uitstel, geplande exposure, geruststellingszoekend gedrag, post-event verwerking, vermijdingslogging, cognitieve naverwerking, exposure-duur.

Let op: variabelen als “prestatieangst”, “ruminatie” of “intrusieve obsessies” zijn klachtdimensies (symptomen) – geen behandelingsopties. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie.

Hoe genereert u behandelingsoptielabels?

Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1 (voorbeeld): S-1: Inslaapmoeilijkheden; S-2: Vroegochtendontwaak; S-3: Vermoeidheid overdag; S-4: Prikkelbaarheid; S-5: Sociale terugtrekking.

Correct ingevulde behandelingsoptielabels:

- **BO-1** Avondschermsgebruik (*modificeerbaar gedrag; EMA: minuten voor slapengaan*)
- **BO-2** Lichaamsbeweging (*modificeerbaar; EMA: minuten actief bewegen per dag*)
- **BO-3** Sociaal contact (*modificeerbaar; EMA: ja/nee contact gezocht op eigen initiatief*)

Dit zijn GEEN behandelingsopties (zijn symptomen, horen in Deel 1):

- “*Vermoeidheid*” → klachtdimensie (= S-2), geen behandeldoel.
- “*Slechte slaap*” → klachtdimensie (= S-1), geen behandeldoel.

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 2

25-jarige postgraduaatsstudent; duur: 18 maanden. Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, situationele vermijding en tijdsbelasting door OCD-rituelen.

Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1:

- **S-1** Intrusieve schadeobsessies
- **S-2** Compulsieve mentale controle
- **S-3** Vermijding van schaderisico
- **S-4** Tijdsbelasting door OCD-rituelen

Uw antwoord

Opdracht: noteer **3–5 behandelingsoptielabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Behandelingsoptie 1 Label: _____

Behandelingsoptie 2 Label: _____

Behandelingsoptie 3 Label: _____

Behandelingsoptie 4 Label: _____

Behandelingsoptie 5 Label: _____

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 2

32-jarige marketingprofessional; duur: 2 jaar. Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van professionele zichtbaarheid.

Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1:

- S-1 Prestatieangst op het werk
- S-2 Post-event ruminatie
- S-3 Excessieve voorbereiding
- S-4 Vermijding van zichtbaarheid

Uw antwoord

Opdracht: noteer **3–5 behandelingsoptielabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Behandelingsoptie 1 Label: _____

Behandelingsoptie 2 Label: _____

Behandelingsoptie 3 Label: _____

Behandelingsoptie 4 Label: _____

Behandelingsoptie 5 Label: _____

4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 gestandaardiseerde behandelingsopties** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

Wat is een behandeldoel? Een behandeldoel is de behandelingsoptie die, als zij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de symptomen oplevert. Prioriteer op basis van monitoringbewijs (frequentie en ernst van het gedragspatroon), klinische modificeerbaarheid (haalbaarheid voor deze persoon) en netwerkimpact (invloed op meerdere symptomen).

Het bipartiet netwerk lezen:

- Behandelingsopties staan in de **linkerkolom (groen)**; symptomen in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** behandelingsoptie heeft een positief verband met het symptoom (meer van BO → meer van S; bijv. meer geruststellingszoekend gedrag → meer obsessies).
- **Rode rand:** behandelingsoptie heeft een negatief verband met het symptoom (meer van BO → minder van S; bijv. meer compulsie-uitstel → minder compulsieve controle).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het empirische verband (21-daagse EMA-data).

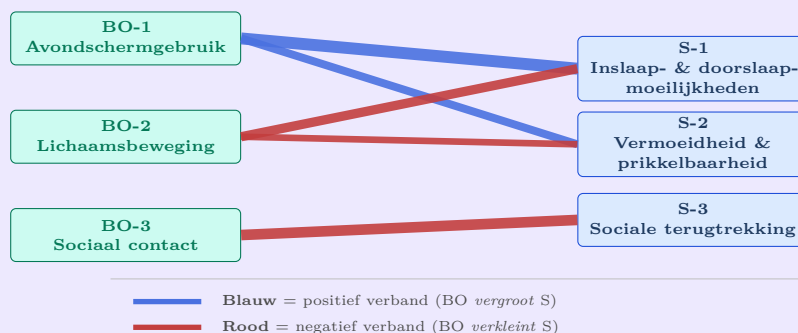
Antwoordformat: vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste prioriteit) tot en met 5 (laagste prioriteit).

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een toelichting op het lezen van het netwerk en de prioriteringslogica.

Hoe leest u het netwerk en rangschikt u de behandelingsopties?

Monitoring (voorbeeld): Schermtijd voor slapengaan: 18/21 avonden actief (gem. 65 min). Lichaamsbeweging: 0,8 sessies/week. Sociaal contact op eigen initiatief: 0,9/week.

Bipartiet netwerk voor dit voorbeeld:



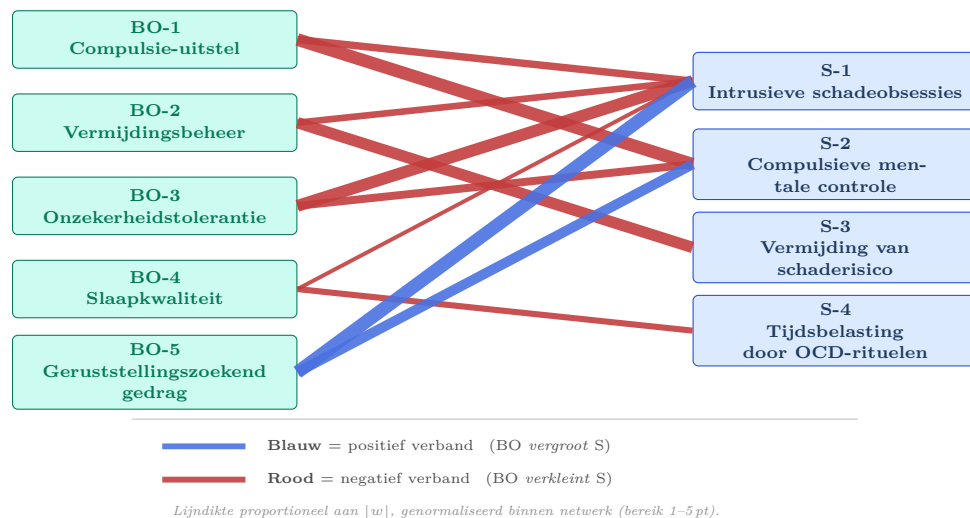
Prioriteringsredenering (voorbeeld):

1. **BO-1 (Avondschermgebruik)** – raakt S-1 en S-2 via sterke blauwe verbanden; monitoring toont 18/21 avonden hoge schermtijd → **prioriteit 1**.
2. **BO-2 (Lichaamsbeweging)** – beschermend effect op S-1 en S-2 (rode verbanden); frequentie extreem laag (0,8/week) → **prioriteit 2**.
3. **BO-3 (Sociaal contact)** – sterk negatief verband met S-3; eveneens laag (0,9/week) → **prioriteit 3**.

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 3

Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, situationele vermijding en tijdsbelasting door OCD-rituelen. Duur: 18 maanden.

21-daagse monitoring: Compulsieve mentale controles en rituelen: gem. 3,1 uur/dag (21/21 dagen). Geruststellingszoekend gedrag: gem. 4,3 keer/dag. Vermijdingsepisodes (angstgerelateerde situaties niet betreden): gem. 2,8/dag. Compulsie-uitstelpogingen: gem. 0,4/dag. Gemiddelde slaaptijd: 6,2 uur/nacht.



Uw antwoord

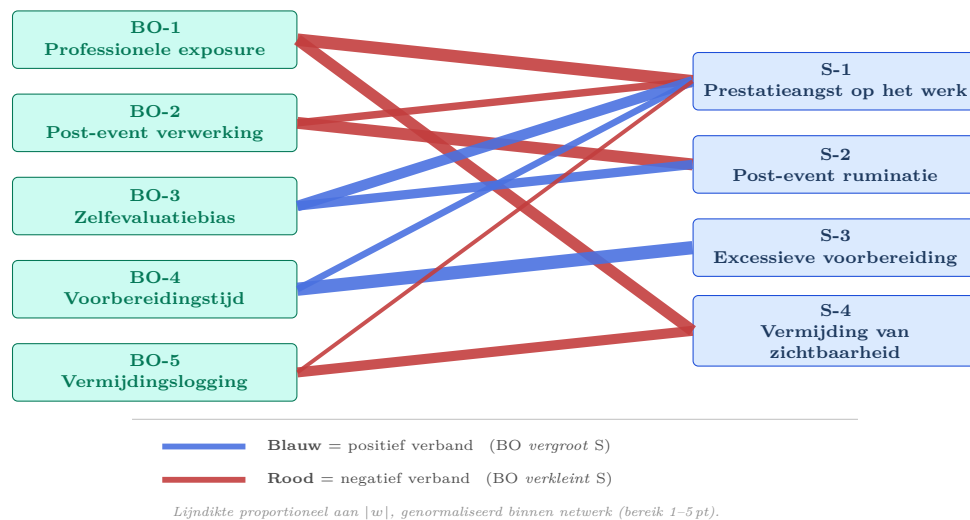
Opdracht: rangschik alle 5 behandelingsopties van hoogste naar laagste behandelprioriteit. Beschikbare behandelingsopties: BO-1: Compulsie-uitstel, BO-2: Vermijdingsbeheer, BO-3: Onzekerheidstolerantie, BO-4: Slaapkwaliteit, BO-5: Geruststellingszoekend gedrag

Prioriteit 1	_____
Prioriteit 2	_____
Prioriteit 3	_____
Prioriteit 4	_____
Prioriteit 5	_____

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 3

Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van professionele zichtbaarheid. Duur: 2 jaar.

21-daagse monitoring: Voorbereidingstijd per werkmoment (vergadering, presentatie): gem. 3,4 uur/dag. Post-event ruminatieduur na werksituaties: gem. 1,8 uur/dag. Vermijding van zichtbaarheid in werk: gem. 2,1 keer/dag. Professionele exposurestappen uitgevoerd: gem. 0,2/dag. Zelfevaluatiescore na sociale werksituaties: gem. 2,4/10.



Uw antwoord

Opdracht: rangschik alle 5 behandelingsopties van hoogste naar laagste behandelprioriteit.
Beschikbare behandelingsopties: BO-1: Professionele exposure, BO-2: Post-event verwerking, BO-3: Zelfevaluatiebias, BO-4: Voorbereidingstijd, BO-5: Vermijdingslogging

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-behandelingsopties per behandel-doel** (3 behandeldoelen $\times$ 2 = 6 items).

Wat zijn sub-behandelingsopties? De gestandaardiseerde behandeldoelen in dit deel zijn *abstracte domeinen* (bijv. “Slaapkwaliteit” of “Voedingskwaliteit”). Om dit domein dagelijks via EMA te monitoren, moet het vertaald worden naar *concrete, specifieke gedragsitems* – de **sub-behandelingsopties**.

Hoe werkt de abstracte-naar-concrete vertaling?

- Een abstract behandeldoel beschrijft een *gedragsdomein* (bijv. Slaapkwaliteit, Voedingskwaliteit).
- Een sub-behandelingsoptie is de *concrete gedragsoperationalisering* van dat domein: een specifiek, dagelijks meetbaar item dat het domein direct meet (bijv. “schermvrij interval voor slapengaan (min)” als sub-optie van “Slaapkwaliteit”, of “gezonde maaltijd genuttigd (ja/nee)” als sub-optie van “Voedingskwaliteit”).
- Selecteer per behandeldoel de 2 items die het domein het *meest direct en precies* meten.
- Vermijd items die het domein slechts *zijdelings* raken – zelfs als ze op het eerste zicht verwant lijken.

Belangrijk: alle 20 items in de lijst zijn behandelingsoptie-type EMA-items (modificeerbare gedragingen en strategieën – *geen* symptomen). Uw taak is te selecteren welke 6 items het best aansluiten bij de 3 gestandaardiseerde behandeldoelen, 2 per doel.

Antwoordformat: vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie van de selectielogica.

Hoe selecteert u de meest passende EMA-items per behandeldoel?

Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract, voorbeeld):

1. Slaapkwaliteit
2. Lichamelijke activiteit
3. Sociaal contact

Selectielogica – hoe kiest u de 2 beste items per doel?

Stel: doel 1 = *Slaapkwaliteit*. U ziet de volgende opties in de lijst:

- ✓ “Schermvrij interval direct voor slapengaan (min)” → **juist** (operationaliseert het domein direct)
- ✓ “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)” → **juist** (complementaire meting: regelmaat)
- × “Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)” → **niet juist** (raakt slaap slechts zijdelings, hoort niet bij Slaapkwaliteit)
- × “Maaltijd op vaste tijden genuttigd (ja/nee)” → **niet juist** (hoort bij Voedingskwaliteit, niet bij Slaapkwaliteit)

Correct ingevuld (6 items totaal voor de 3 doelen):

- Doel 1 → “Schermvrij interval voor slapengaan (min)” + “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)”
- Doel 2 → “Duur actieve beweging vandaag (min)” + “Beweegactiviteit uitgevoerd (ja/nee)”
- Doel 3 → “Bewust sociaal contact gezocht vandaag (ja/nee)” + “Sociale activiteit bijgewoond of gepland (ja/nee)”

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 4**Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract) voor Deel 4:**

1. **Compulsie- en ritueeluitstel**
2. **Gedragsexperiment en situatiebetreding**
3. **Onzekerheids- en intrusietolerantie**

Uw antwoord

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best aansluiten als sub-behandelingsopties. *Alle 20 items zijn dagelijkse mobiele EMA-items (behandelingsoptie-type, geen symptomen). In het Word-document kunt u de vakjes (□) omcirkelen of markeren in plaats van aanvinken.*

1. ☐ Slaaptijd gisteravond bijgehouden (uren)
2. ☐ Compulsieve handeling of mentaal ritueel bewust uitgesteld bij impulsdrang (ja/nee)
3. ☐ Geruststellingsvraag aan anderen gesteld vandaag (aantal)
4. ☐ Tijdsduur mentaal ritueel met opzet vertraagd of afgebroken (min)
5. ☐ Cafeïne-inname vandaag (aantal dranken)
6. ☐ Bewuste ontspanningsoefening of ademhaling uitgevoerd (min)
7. ☐ Situatie die OCD-angst uitlokt bewust opgezocht of niet verlaten (ja/nee)
8. ☐ Alcoholinname gisteravond (eenheden)
9. ☐ Wandeling of lichaamsbeweging vandaag (min)
10. ☐ Gedragsexperiment volledig doorlopen zonder tussentijdse mentale controle (ja/nee)
11. ☐ Werkuren vandaag (uren)
12. ☐ Maaltijd op vaste tijden genuttigd (ja/nee)
13. ☐ Intrusieve gedachte bewust getolereerd zonder compulsieve of vermijdende reactie (ja/nee)
14. ☐ Stappentelling overdag (stappen)
15. ☐ Sociaal contact op eigen initiatief gezocht vandaag (ja/nee)
16. ☐ Onzekerheid bij OCD-situatie bewust verdragen zonder geruststelling of controle (min)
17. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
18. ☐ Bewuste mindfulness- of aandachtsoefening uitgevoerd (min)
19. ☐ Werk-privelimit bewust aangehouden vandaag (ja/nee)
20. ☐ Schermtijd voor slapengaan (min)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract) voor Deel 4:

1. Professionele exposure en gedragsexperiment
2. Cognitieve naverwerking en ruminatiebeheer
3. Vermijdingsmonitoring en bewustwording

Uw antwoord

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best aansluiten als sub-behandelingsopties. *Alle 20 items zijn dagelijkse mobiele EMA-items (behandelingsoptie-type, geen symptomen). In het Word-document kunt u de vakjes (☐) omcirkelen of markeren in plaats van aanvinken.*

1. ☐ Slaaptijd gisteravond (uren)
2. ☐ Presentatie, vergadering of zichtbaar werkmoment bewust opgezocht of deelgenomen (ja/nee)
3. ☐ Lichaamsbeweging vandaag (min)
4. ☐ Alcoholinname vanavond (eenheden)
5. ☐ Exposurestap in werksituatie volledig doorlopen zonder vroegtijdig terugtrekken (ja/nee)
6. ☐ Maaltijd op vaste tijden genuttigd (ja/nee)
7. ☐ Post-event ruminatie bewust afgesloten via schrijfoefening of afsluitritueel (ja/nee)
8. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
9. ☐ Stappentelling overdag (stappen)
10. ☐ Tijdsduur piekeren over werkprestatie bewust beperkt of omgeleid (min)
11. ☐ Sociaal contact op eigen initiatief buiten werk gezocht (ja/nee)
12. ☐ Schermtijd voor slapengaan (min)
13. ☐ Vermijdingsepisode in werksituatie geregistreerd in dagboek (ja/nee)
14. ☐ Cafeïne-inname vandaag (aantal dranken)
15. ☐ Bewuste ontspanningsoefening of ademhaling uitgevoerd (min)
16. ☐ Aantal situaties waarbij zichtbaarheid of beoordeling bewust vermeden werd vandaag (aantal)
17. ☐ Werkuren vandaag (uren)
18. ☐ Geruststellingsvraag aan collega of leidinggevende gesteld (aantal)
19. ☐ Voorbereidingstijd voor vergadering of presentatie vandaag (min)
20. ☐ Middagpauze bewust weggestapt van werkplek (ja/nee)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

Theoretisch kader – HAPA: PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

De boodschap voldoet aan:

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een volledige illustratie.

Hoe formuleert u een effectieve coachingsboodschap?

Context (voorbeeld):

- Primair behandeldoel: avondschermgewbruik verminderen
- Voornaamste barriere: gewoontekracht – schermgebruik is de enige manier om na het werk te ontspannen (lage zelfeffectiviteit)
- HAPA-fase: intentioneel (wil veranderen, maar heeft nog geen concreet plan)

Voorbeeldboodschap:

“Je weet dat je avondscherme je slaap in de weg staat, maar het voelt nog als de makkelijkste manier om te ontspannen na een drukke dag. Leg vanavond je telefoon om 21.30 uur in een andere kamer en vul die laatste twintig minuten met iets anders – een boek, muziek, of gewoon even niets. Een avond is genoeg om te merken dat het kan.”

Waarom werkt deze boodschap? De boodschap erkent de barriere (gewoontekracht), geeft een concrete actie met tijdstip (21.30u), verlaagt de drempel (“gewoon even niets”) en vergroot de zelfeffectiviteit (“een avond is genoeg”).

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 5**Primair probleem**

OCD met schadeobsessies en compulsieve mentale controle die dagelijks twee tot vier uur opsloort en het dagelijks functioneren ernstig beperkt.

Behandeldoel

Compulsie-uitstel: bewust en gradueel uitstellen van mentale controles en rituelen bij elke obsessionele impulsdrang.

Voornaamste barriere

Hoge morele verantwoordelijkheidsbeleving; het nalaten van het ritueel voelt als onverantwoordelijk handelen en roept intense schuld op.

Copingstrategie

Implementatie-intentie met vastgelegd uitstelprotocol (bijv. 15 minuten wachten), gecombineerd met herattributie van de verantwoordelijkheidsgedachte.

Uw antwoord

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 5

Primair probleem

Prestatieangst en post-event ruminatie leiden tot toenemende professionele vermijding en loopbaanschade.

Behandeldoel

Professionele exposure: bewust deelnemen aan beoordeelbare werksituaties zonder terugtrekking of overmatige voorbereiding.

Voornaamste barriere

Negatieve uitkomstverwachting en zelfevaluatie: de persoon verwacht definitieve afwijzing of beoordeling als incompetent bij elk zichtbaar moment.

Copingstrategie

Gedragsexperiment met vooraf geformuleerde toetsingshypothese en een vaste tijdslimiet voor post-event evaluatie (max. 10 minuten).

Uw antwoord

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen symptoomlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen behandelingsoptielabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 behandelingsopties gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-03

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.